

Ống dẫn hồi tràng

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Phương pháp dẫn lưu nước tiểu qua lỗ mở ra túi chứa

Ống dẫn hồi tràng (ileal conduit) là cách dẫn lưu nước tiểu sau khi bàng quang bị cắt bỏ hoặc không còn hoạt động. Bác sĩ dùng một đoạn ruột ngắn của chính bạn để dẫn nước tiểu từ thận ra một lỗ mở nhỏ trên bụng (stoma), từ đó nước tiểu chảy vào túi nhỏ bạn đeo bên ngoài. Đây là phương pháp dẫn lưu nước tiểu đơn giản và phổ biến nhất.

Về ca phẫu thuật này

Một **đoạn ruột non dài khoảng 15–20 cm** được dùng làm **ống dẫn** — không chứa nước tiểu. Các niệu quản (ống dẫn từ thận) được nối vào đoạn ruột này, và một đầu được đưa ra da bụng thành **lỗ mở (stoma)**, thường ở phía dưới bên phải. Vì nước tiểu chảy ra **liên tục**, bạn đeo một **túi chứa nước tiểu (ostomy bag)** bên ngoài stoma, đổ túi nhiều lần mỗi ngày và thay túi vài ngày một lần.

- **Không cần kiểm soát và không cần tự thông tiểu.**
- Phần ruột còn lại được **nối lại**, tiêu hóa vẫn bình thường.
- **Y tá chuyên về stoma** sẽ hướng dẫn bạn chăm sóc stoma và túi chứa.

Có an toàn không?

Ống dẫn hồi tràng là phương pháp dẫn lưu tiểu tiêu chuẩn được dùng hơn 70 năm — đơn giản nhất, thời gian phẫu thuật ngắn nhất. Như mọi phẫu thuật lớn, vẫn có nguy cơ (chảy máu, nhiễm trùng, rò chỗ nối ruột hoặc niệu quản). Theo thời gian, một số người gặp vấn đề về stoma, da, nhiễm trùng tiểu, hoặc thay đổi muối/vitamin — tất cả được theo dõi khi tái khám.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Dẫn lưu nước tiểu

Con đường mới để nước tiểu ra khỏi cơ thể khi bàng quang bị cắt hoặc không hoạt động.

Ống dẫn hồi tràng

Đoạn ruột non ngắn dẫn nước tiểu ra lỗ mở trên da bụng.

Lỗ mở (Stoma)

Lỗ nhỏ trên bụng, làm từ ruột, nơi nước tiểu chảy ra ngoài.

Túi chứa nước tiểu (Ostomy bag)

Túi đeo bên ngoài stoma để thu nước tiểu.

Niệu quản

Ống dẫn nước tiểu từ thận; được nối vào ống dẫn hồi tràng.

Y tá stoma

Y tá đánh dấu vị trí stoma và hướng dẫn chăm sóc stoma và túi chứa.

Chất nhầy

Dịch trơn do ruột tiết ra; các sợi nhầy trong nước tiểu là bình thường.

Da quanh stoma

Vùng da xung quanh stoma, cần giữ sạch và bảo vệ.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Sau đó, bụng sẽ đau nhức và ruột cần vài ngày để “hoạt động trở lại” (bắt đầu bằng nước lỏng rồi tăng dần). Bản thân stoma không có cảm giác. Hầu hết bệnh nhân nằm viện khoảng 5–7 ngày.

Cách chuẩn bị (Trước phẫu thuật)

- Phẫu thuật dưới **gây mê toàn thân** — làm đúng hướng dẫn (nhịn ăn, ngừng thuốc theo chỉ định, kể cả thuốc làm loãng máu). Bạn có thể cần **chuẩn bị ruột** trước.
- Gặp **y tá stoma** để được đánh dấu vị trí stoma khi bạn ngồi, đứng và nằm — bước này quan trọng để túi vừa khít, không bị rò.
- **Không hút thuốc** — thuốc lá làm chậm lành thương — và nhờ người hỗ trợ tại nhà sau mổ.

Báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Đang dùng **thuốc làm loãng máu** hoặc đang bị nhiễm trùng
- Có **bệnh đường ruột** (như Crohn’s hoặc viêm đại tràng), từng phẫu thuật bụng hoặc xạ trị

Quá trình phẫu thuật

1. Bạn được gây mê và tiêm kháng sinh.
2. Một đoạn ruột ngắn được tách ra; phần ruột còn lại được nối lại.
3. Các niệu quản được nối vào đoạn ruột này.
4. Một đầu được đưa ra da bụng tạo thành stoma; đặt ống dẫn lưu mềm trong khi lành thương.

Sau phẫu thuật

- Về nhà sau khoảng **5–7 ngày**. Y tá stoma hướng dẫn bạn **đổ túi** (nhiều lần mỗi ngày) và **thay túi** (vài ngày một lần).
- Các sợi **chất nhầy** trong nước tiểu là bình thường — do ruột tiết ra.
- **Uống nhiều nước** và chăm sóc da quanh stoma.
- **Tránh mang vác nặng khoảng 6 tuần**. Bạn cần tái khám suốt đời (kiểm tra chức năng thận, vitamin B12).

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc hoặc đến cơ sở y tế nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Stoma chuyển màu **tối, tím tái hoặc thụt vào trong**
- **Rất ít hoặc không có nước tiểu** trong túi trong vài giờ
- Đau bụng dữ dội, nôn ói, hoặc **không có hơi và không đi tiêu được**
- Chảy máu nhiều, hoặc vết thương đỏ, có dịch chảy ra

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Ống dẫn hồi tràng dùng đoạn ruột ngắn để dẫn nước tiểu ra lỗ mở trên bụng vào túi chứa — phương pháp dẫn lưu đơn giản nhất, không cần tự thông tiểu.
2. Chuẩn bị: làm đúng hướng dẫn nhịn ăn và chuẩn bị ruột, gặp y tá stoma để đánh dấu vị trí, không hút thuốc và nhờ người hỗ trợ tại nhà.
3. Chất nhầy trong nước tiểu là bình thường; y tá stoma sẽ hướng dẫn chăm sóc túi và da. Gọi ngay nếu sốt, stoma tối màu, không có nước tiểu trong túi, hoặc bụng không có hơi và không đi tiêu được.